

智灵动力 Q&A 报告

Q1：智灵动力是什么项目，目前处于什么阶段？

现有证据仅能将智灵动力置于 AI 医疗相关赛道，尚不能确认其公司主体、具体产品、目标科室、付费客户或商业化阶段。[尚无可核验证据] 因此，现阶段不能把项目表述为“已产品化”“已进入医院”或“已实现商业化”，也不能形成关于技术壁垒、收入质量或投资价值的确定判断。

项目定义需先回答四个基础问题：产品服务谁，是医院、医生、患者、药械企业还是科研机构；解决何种流程，是辅助诊断、病历生成、患者服务、医院管理、医学检验还是药物研发；交付形态是软件许可、SaaS、私有化部署、软硬件一体机还是项目制服务；当前状态是研发、内部测试、医院 POC、注册申报、签约、交付、验收、收入确认或回款。上述状态之间不可互相替代。

在项目主体和产品未确认前，最稳妥的内部定位是“AI 医疗方向待识别项目”。下一步应取得营业执照、公司简介、产品清单、系统演示、商业化台账及监管分类意见，并由创始人和产品负责人共同确认一页式业务定义。若项目实际并非 AI 医疗，应立即重做行业、竞品与合规分析。

Q2：行业机会与客户痛点是否成立？

AI 医疗的方向性需求成立，但行业增长不能自动证明智灵动力拥有可获取的市场。医疗机构的核心诉求通常集中在减轻医护文书与重复劳动、提高诊疗质量、改善患者流程、加强运营和质控，以及缓解基层专业能力不足。2024 年发布的《卫生健康行业人工智能应用场景参考指引》覆盖 84 类应用场景，说明政策层面对 AI 进入临床、管理、基层和公共卫生流程给出了较广的应用边界。

行业同时具有明显分化：低风险、非诊断类场景通常更易部署；直接影响诊断治疗的产品需要更严格的临床验证、医疗器械注册及质量管理。医院信息系统标准不一、数据孤岛、预算与采购周期、私有化算力成本和持续运维投入，都会使“有需求”与“愿付费、可复制”之间出现较大距离。行业市场规模的不同统计口径差异显著，不宜用一个宽口径总规模推导项目收入空间。[多来源口径冲突]

智灵动力必须用目标客户的现行流程证明痛点，而非仅依赖行业趋势。需要补充至少三类同场景客户访谈，量化现有流程的人时、错误率、等待时间、单次成本或收入损失，并提供预算归口和采购决策链。若产品不能带来可量化改善，或改善价值低于采购、集成和维护成本，需求可能停留在试点层面。

Q3：产品与技术是否解决关键问题？

现有证据不能确认智灵动力的产品架构、数据输入、核心模型、输出结果及反馈闭环。
[尚无可核验证据] 对 AI 医疗项目，技术判断不应只看模型演示，而应同时审查数据合法性、临床有效性、系统稳定性、可解释性、安全性及工作流适配。

技术核验应沿“数据输入—模型或规则引擎—业务输出—人工复核—结果反馈”展开。公司需说明哪些模块自主研发，哪些依赖开源模型、第三方大模型、云服务或医疗信息化厂商；训练、验证和测试数据如何分离；数据是否取得合法授权；关键指标在何种人群、机构、设备和样本量下产生；跨医院、跨设备和罕见病例是否出现性能衰减。内部测试不能等同于第三方测试，单中心结果也不能直接推导多中心泛化能力。

若产品触及诊断、治疗建议或高风险临床决策，还应提供监管分类、临床评价路径、注册计划和算法更新控制方案；若定位为流程提效工具，也需证明错误输出不会被医生或患者误用。建议由临床专家、算法专家、医疗器械法规顾问和医院信息科分别完成独立评审，在此之前不宜认定技术已达到临床可用或规模交付状态。

Q4：核心优势与竞争差异是否可信？

智灵动力尚无可核验的性能、客户、注册、数据资源或知识产权证据，当前不能确认其竞争壁垒。[尚无可核验证据] AI 医疗竞争者不仅包括同类创业公司，也包括大型医疗设备商、医疗信息化厂商、互联网平台、通用大模型供应商、医院自研团队，以及医生人工流程和“不采购”选项。

行业对标显示，成熟参与者往往依靠多项能力组合：合规且可持续的数据来源、深度医院合作、注册证或临床验证、与 HIS/EMR/PACS 等系统的集成经验、稳定交付与售后，以及可持续资金投入。仅有算法准确率、低价格或一次性定制能力，通常难形成长期壁垒；基础模型能力提升还可能压缩通用问答、文本生成等功能的差异化空间。

公司应提交同场景竞品矩阵，以相同测试集和同一业务流程比较准确性、召回率、幻觉率、响应延迟、部署周期、接口兼容、客户总成本及监管状态，并说明失败案例。真正可投资的优势应同时满足“客户在意、可量化、难复制、可持续”。若差异主要来自创始人关系、单一医院数据或人工服务，需评估关系中断、数据不可续用和人效约束。

Q5：商业模式能否产品化与规模化？

现有证据不能确认智灵动力采用软件许可、订阅、调用量计费、硬件销售、实施服务或科研合作模式，也不能判断收入是否具有重复性。[尚无可核验证据] 医疗 AI 常见的商业化障碍是项目制收入看似增长，但每家医院都需要重新集成、标注、调参和驻场，导致收入与人员同步增长，毛利和现金流难以改善。

产品化应通过五项指标验证：标准模块占比、单院部署周期、单项目定制人天、可复用接口或组件比例、上线后的续费与扩科室情况。公司还需拆分软件、硬件、实施、运维和第三方算力成本，说明毛利率口径及售后责任。若依赖医院本地 GPU、第三方大模型或信息化厂商，应将推理成本、适配费用、涨价风险和服务等级协议纳入单位经济模型。

建议选择一个高频、强痛点、预算归口清晰的场景作为标准产品，先验证三家不同信息化条件客户的复制效率。若第十家客户的部署成本没有明显低于第一家，或续费依赖新增定制功能，则公司更接近医疗 IT 项目交付商而非可规模化软件企业，估值方法也应相应调整。

Q6: 客户、订单、交付、收入和回款是否得到验证?

目前没有客户名单、合同、订单、交付单、验收报告、发票、收入明细或银行流水支持智灵动力的商业化进展。[尚无可核验证据]任何“合作医院”“覆盖客户”“在手订单”或“收入增长”的表述均不应进入投资判断，直至取得对应证据。

客户进展必须按线索、需求确认、Demo/POC、测试、招投标、签署合同、交付、验收、收入确认、回款和复购逐项列示。合作协议或联合实验室不等于采购，POC 不等于订单，交付不等于验收，收入也不等于现金。公司应按客户别名提供合同金额、产品、当前阶段、预计日期和证据，并披露前五大客户集中度、销售周期、POC 转化率、应收账款账龄和回款条件。

核验应抽取至少三类客户：最大收入客户、最新签约客户及已流失或未转化客户，由投资团队直接访谈业务使用者、信息科、采购或财务人员。重点确认产品实际使用频率、关键效果、验收条件、预算来源、续费意愿及是否存在关联交易。无法形成合同—验收—发票—流水闭环时，商业化证据应视为不足。

Q7：团队、治理、知识产权与合规基础是否稳定？

现有证据未披露创始人、核心管理层、股权结构、历史融资、员工构成、知识产权或监管资质。[尚无可核验证据] 团队评估需要覆盖临床理解、算法研发、产品、医院销售、交付、医疗器械法规、数据安全和财务管理，不能仅凭名校或大厂经历判断执行力。

公司应提供全职证明、劳动或顾问协议、竞业限制、历史任职成果和关键人依赖情况；提供完整股权穿透、代持清理、员工期权、关联方交易及董事会安排。对于高校、医院或前雇主背景技术，应核验职务成果归属、技术转让或许可范围、独占性、期限及再许可权。

知识产权核验应覆盖专利、软件著作权、源代码、商标、模型权重、数据集与标注成果。医疗数据还需说明采集目的、授权链、脱敏、存储地点、访问控制、跨机构使用、模型训练与二次利用边界。产品若涉及医疗器械、生成式 AI 服务或互联网诊疗相关活动，应取得专业法规意见并核实所需注册、备案和许可；缓释方案不能替代已经完成的合规证据。

Q8：财务质量、资金需求与交易条件是否可控？

智灵动力的历史收入、毛利、费用、现金余额、应收账款、负债、融资需求、估值和交易条款均缺失，无法判断资金安全边际或本轮定价合理性。[尚无可验证证据] 在 AI 医疗项目中，研发、临床验证、注册、医院销售、私有化部署和长期运维均可能形成持续现金消耗，且回款通常晚于合同签署。

公司应提交至少两年及最新一期利润表、资产负债表、现金流量表、科目余额表、纳税申报、银行流水和应收账款账龄，并将收入按合同、验收、开票和回款四个口径勾稽。预算应拆分研发、算力、数据、注册临床、销售、实施和售后支出，给出未来 18 个月月度现金计划及下行情景。

交易评估还需明确投前和投后估值、融资金额、资金用途、创始人稀释、清算优先、回购、反稀释、优先认购、董事席位及关键人条款。估值不能只以 AI 医疗赛道热度或宽口径市场规模支撑，应与已验证收入、复购、产品成熟度和监管里程碑匹配。在财务和条款资料补齐前，不建议进入定价谈判。

Q9：主要风险与最强反方观点是什么？

最强反方观点是：智灵动力可能只是处于概念或试点阶段的 AI 医疗项目，尚未证明数据、技术、合规、付费和规模复制闭环；通用大模型、成熟医疗 IT 厂商及医院自研能力又可能快速削弱其功能差异。在缺乏项目级证据的情况下，这一反方观点不能被排除。

（1）项目身份与定位不清

概率高、影响高。若公司无法说明单一核心产品、目标客户和应用场景，应先固化一页式业务定义，并核验主体、产品清单、系统演示及负责人访谈。

（2）技术与数据壁垒不足

概率高、影响高。预警信号包括依赖通用模型、缺少独立测试或数据授权不完整；应核验数据授权、测试报告和模型依赖清单，并判断能否在专病或关键 workflows 中形成闭环。

（3）临床及监管不确定

概率中高、影响高。若产品触及诊疗但缺少分类意见或注册路径，应提前完成法规与临床方案设计，并核验分类界定、注册计划和质量体系。

（4）商业化停留在 POC

概率高、影响高。若合作数量较多但合同、验收和回款较少，应设置 POC 转签及回款门槛，并核验客户台账、合同、验收材料和银行流水。

（5）项目定制难以规模化

概率中高、影响高。若部署周期较长、驻场人员随收入同步增长，应推进接口模块化和交付标准化，并核验定制人天、组件复用率和部署周期。

（6）数据安全和隐私

概率中高、影响高。若授权链不清、存在跨机构训练或访问控制薄弱，应实施数据最小化与全流程治理，并核验数据地图、授权文本和安全审计。

（7）现金流及融资风险

概率高、影响高。长回款周期叠加持续研发和注册投入时，应采用分阶段融资并绑定里程碑，同时核验月度现金流、应收账款龄和融资条款。

（8）关键人和权属风险

概率中、影响高。若核心技术集中于个人或来源于高校、医院，应完善任职、竞业和权属安排，并核验股权结构、劳动协议和技术许可。

风险概率属于基于当前资料缺口的项目团队判断，并非对公司事实的认定。若后续取得高等级证据，应逐项更新；若关键合同、数据授权或合规路径无法补齐，则风险可能直接破坏投资逻辑。

Q10：下一阶段应验证什么，如何形成决策？

当前更适合“暂缓投资判断、进入限时资料核验”，而非直接推荐或否决。支持继续核验的依据有三点：AI 医疗存在明确的政策和效率驱动场景；医院数据与 workflow 形成较高进入门槛；细分产品一旦同时完成临床、监管和付费验证，可能具备较强客户黏性。限制推进的核心问题也有三项：项目身份与产品不清、商业化闭环无证据、财务和交易信息完全缺失。

(1) 最高优先级：确认公司、产品与商业闭环

建议在 5 个工作日内由创始人和产品负责人提交营业执照、组织架构、产品清单并完成现场演示；无法形成清晰业务定义则停止评估。建议在 10 个工作日内由销售及财务负责人提交全量客户台账和抽样合同、验收、发票、流水，并安排最大收入、最新签约及未转化客户访谈；该项决定商业化真实性。

(2) 最高优先级：确认技术、数据与监管可行性

建议在 10 个工作日内由 CTO 和临床负责人提交数据授权链、模型清单、测试集说明及第三方或多中心验证；由法规负责人和外部律师提交产品分类意见、注册或备案路径及数据合规审计。重大数据或监管缺陷可构成否决项。

(3) 第二优先级：确认财务、团队与交易基础

建议在 10 个工作日内由财务负责人提交两年及最新一期财务、银行流水、应收账款和 18 个月预算；由创始人和法务提交核心团队简历、劳动与竞业协议、股权穿透、知识产权及技术许可；由创始人提交融资方案、投前投后估值、资金用途与核心交易条款。上述资料分别决定资金安全边际、关键人与权属风险以及风险收益匹配度。

继续推进的最低门槛应包括：确认清晰且可演示的核心产品；至少形成一组可独立核验的客户使用与付费证据；数据来源和产品合规路径不存在不可纠正缺陷；技术效果经独立或多中心证据支持；未来 18 个月资金计划可覆盖关键里程碑。若仅有战略合作、内部测试或收入预测，建议继续观察；若发现数据使用无合法基础、核心知识产权不归公司、重大收入无法勾稽或关键合同虚假，应停止投资流程。关键资料齐备后，再开展正式立项、估值比较与交易条款谈判。